

**PIC > 22 mmHg
(ou signes d'engorgement)**



1. ACSOS corrigées ?
PA, SpO₂, PaCO₂, natrémie,
Hb, température, glycémie



2. Le capteur dit-il vrai ?
zéro, courbe, clinique



3. Cause chirurgicale ?
scanner : hématome, contusion
qui gonfle, hydrocéphalie

non →



**Chirurgie : évacuation,
DVE, décompression**

Palier 3

barbituriques titrés sur la PIC ;
hypothermie 35–36 °C ;
craniectomie décompressive

Palier 2

PaCO₂ 32–35 mmHg ;
curarisation, gardée si efficace ;
test de la PAM si autorégulation conservée

Palier 1

PPC 60–70 mmHg ; sédation approfondie ;
PaCO₂ 35–38 mmHg ; osmothérapie en bolus ;
drainage du LCR ; EEG

Palier 0 : socle, pour tous

tête 30–45°, sédation-analgésie, T° ≤ 38 °C,
SpO₂ ≥ 94 %, EtCO₂, PPC ≥ 60 mmHg,
Hb > 7 g/dL, pas d'hyponatrémie

intensité et risque croissants ↑

*Refaire ces trois vérifications
à chaque changement de palier.*

PIC non contrôlée : palier suivant (on peut en sauter un)